

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009553-40.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ANA PAULA DOS SANTOS MOREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5009553-40.2025.4.02.5101

510015654473 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009553-40.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ANA PAULA DOS SANTOS MOREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, com pedido de liminar, na qual ANA PAULA DOS SANTOS MOREIRA objetiva atribuir efeito suspensivo ativo à decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela definitiva, por meio da qual a parte pleiteia a realização de consulta em ambulatório de cirurgia bariátrica.

A liminar foi indeferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, verbis: (processo 5106203-86.2024.4.02.5101/RJ, evento 18, DOC1)

"Trata-se de ação proposta por ANA PAULA DOS SANTOS MOREIRA, em face da UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, postulando liminarmente, a condenação da Rés a providenciarem CONSULTA AMBULATORIAL DE CIRURGIA BARIÁTRICA. No mérito, requer a confirmação da tutela.

Como causa de pedir, sustenta em síntese que no dia 22/09/24 foi diagnosticada com Obesidade, Transtorno de Personalidade Borderline, Transtorno Afetivo Bipolar com episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos, Transtorno de personalidade com instabilidade emocional.

Informa que devido a seu peso apresenta dores articulares e na coluna lombar, sendo encaminhada para a realização de uma ressonância magnética em 20/05/2024, que aguarda até a presente data para a sua realização.

Afirma que foi encaminhada para a consulta em ambulatório para cirurgia bariátrica e incluída no SISREG em 06/06/24 e se encontra em fila para atendimento.

Documentos que instruem a inicial - Evento 1 - anexos 2 a 26 e Evento 11.

Evento 16 - Parecer do NAT, acatado pelo Juízo, no sentido de que a consulta médica em cirurgia bariátrica está indicada ao quadro clínico apresentado pela Autora. Informa que a parte autora foi inserida no SER em 06/06/24 e se encontra em fila. Esclarece que a via administrativa já está sendo utilizada para o caso em tela, contudo sem resolução do mérito até a presente data.

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, já que a parte autora obedece aos requisitos traçados no art. 98 do CPC. Caso a parte ré deseje impugnar o presente deferimento de gratuidade de justiça, deverá fazê-lo no prazo da contestação, sob pena de preclusão.

Entende-se que o pedido de tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, possui como pressuposto "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". Trata-se de providência protetiva do bem jurídico tutelado pelo direito, com a função de assegurar a entrega efetiva da prestação jurisdicional.

Para a obtenção da antecipação da tutela, a parte autora deve demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria manifestação final do Poder Judiciário. E isso, somente, pode acontecer quando efetivamente ocorrer o risco de perecimento e destruição, desvio, deteriorização ou qualquer tipo de alteração no estado das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficiente atuação do provimento final de mérito.

Ocorre que, no presente caso, em que pese haver provas que atestam a verossimilhança das alegações autorais, ao menos no que pertine a ser, de fato, a parte requerente portadora da doença que indica na inicial, faltam conhecimentos técnicos a este Juízo para apurar se, de fato, a condição clínica da parte autora a impossibilita de aguardar o atendimento, ofertado pelo SUS, na fila de espera existente para tanto. E, vale dizer, na aplicação do Direito deve o magistrado pautar-se na aplicação do princípio da igualdade material, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Ocorre, porém, que não há nos autos elementos suficientes para que tal desigualdade da parte autora, face aos demais que aguardam atendimento/cirurgia na mesma fila de espera, fique caracterizada., uma vez que a tutela antecipatória acaba tendo cunho satisfativo, mas não apenas cautelar, pode ocorrer, na prática, que o Juízo, tentando fazer justiça no caso concreto, venha a prejudicar terceiros que aguardam a fila de espera para adequado atendimento, e eventualmente terceiros que possam ter uma urgência no atendimento mais premente que a da parte autora.

Não é de desconhecimento deste Juízo o quadro caótico em que se encontra a saúde pública no país, entretanto, torna-se extremamente pernicioso que uma infinidade de tutelas com teor igual ao ora pretendido sejam concedidas, sob pena de passar o Judiciário, e, não, o Administrativo, a promover as políticas públicas, políticas essas que nunca devem perder a perspectiva da melhor tutela para toda a coletividade.

Desta forma, não pode o Poder Judiciário interferir na execução das Políticas Públicas de implementação de assistência médico-hospitalar, o qual se direciona através do poder-dever de agir, que atua voltado para gerir bem os interesses da coletividade.

Neste sentido, não pode o administrador preferir NENHUM administrado em detrimento de outro, ou seja, como no caso em tela, tal como alegado pelos réus, em suas contestações, com razão, sob pena de estar cometendo uma injustiça perante aos que já estão em fila de espera, não atendendo ao Princípio da Impessoalidade, o qual determina que a Administração Pública deve oferecer igualdade de tratamento aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.

Conforme Parecer do NAT - Evento 16, a consulta médica em cirurgia bariátrica está indicada ao quadro clínico apresentado pela Autora. Informa que a parte autora foi inserida no SER em 06/06/24 e se encontra em fila. Esclarece que a via administrativa já está sendo utilizada para o caso em tela, contudo sem resolução do mérito até a presente data, senão vejamos:

Em síntese, trata-se de Autora com diagnóstico de **obesidade mórbida**, cursando com hipertensão arterial, diabetes mellitus e quadro depressivo, além de dificuldade para deambular (Evento 1, ANEXO11, Páginas 1 e 2), solicitando o fornecimento de **consulta médica em cirurgia bariátrica** e subsequente **tratamento cirúrgico** (Evento 1, INIC1, Página 9). Tendo em vista que somente após a avaliação do médico especialista é que será definida a melhor estratégia terapêutica para a Autora, este Núcleo discorrerá sobre os aspectos inerentes à obtenção da consulta vindicada.

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Sobrepeso e Obesidade em Adultos, o **sobrepeso e a obesidade** têm implicações relevantes à saúde do indivíduo e à sociedade. Valores de índice de massa corpórea (IMC) acima da normalidade estão relacionados a um maior risco para doenças crônicas não transmissíveis (DNCT), como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças musculoesqueléticas e alguns tipos de câncer, além de estar associado a maiores índices de mortalidade. A **indicação de cirurgia bariátrica** como tratamento de obesidade deverá seguir os critérios dispostos no ANEXO I da Portaria do Ministério da Saúde nº 424, de 19 de março de 2013¹.

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 424, de 19 de março de 2013, são consideradas indicações para cirurgia bariátrica: a) indivíduos que apresentem IMC 50 Kg/m²; b) indivíduos que apresentem IMC 40 Kg/m², com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado, na Atenção Básica e/ou na Atenção Ambulatorial Especializada, por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos; c) indivíduos com IMC > 35 kg/m² e com comorbidades, tais como pessoas com alto risco cardiovascular, diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, apnéia do sono, doenças articulares degenerativas, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos. O acompanhamento pré e pós-operatório deve ser realizado pela equipe multiprofissional do Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade².

Diante do exposto, informa-se que a **consulta médica em cirurgia bariátrica está indicada** ao quadro clínico apresentado pela Autora – **obesidade mórbida** (Evento 1, ANEXO11, Páginas 1 e 2).

Quanto à disponibilização do atendimento, informa-se que este procedimento **está coberto pelo SUS**, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual consta: consulta médica em atenção

¹ Comitê. Relatório de Recomendação: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Sobrepeso e Obesidade em Adultos. Julho/2020. Disponível em: < http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Relatorio_PCDT_Sobrepeso_Obesidade_em_Adultos_CP_25_2020.pdf >. Acesso em 18 jul. 2024.

² BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 424, de 19 de março de 2013. Estabelece regulamento técnico, normas e critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade. Disponível em: < http://brs.saude.gov.br/bvs/saudeleg/gm/2013/port424_19_03_2013.html >. Acesso em: 18 jul. 2024.



1

Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Subsecretaria Jurídica

Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

especializada, sob o código de procedimento 03.01.01.007-2, considerando-se o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Visando identificar o correto encaminhamento da Autora aos sistemas de regulação, foi realizada pesquisa na plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER, onde foi identificada solicitação de consulta em **Ambulatório 1ª vez- Cirurgia Bariátrica (Adulto)**, inserida em 06/06/2024 pela Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba, para o tratamento de obesidade, com situação **"Em fila"**, ocupando atualmente a posição de número 2.779 na lista de espera (**ANEXO I**).

Assim, entende-se que a via administrativa já está sendo utilizada para o caso em tela, contudo sem resolução do mérito até a presente data.

É o parecer.

À 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

Em face do exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC e INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

Entretanto, faculto à parte autora a juntada de documentos que atestem, peremptoriamente, mediante laudo médico elaborado por médico do SUS, que não se encontra em estado de saúde que lhe permita aguardar a fila de espera existente para que venha a obter o tratamento/cirurgia requeridos.

Deixa-se claro, por oportuno, que se trata de decisão proferida em cognição sumária, reversível, pois, a qualquer tempo, desde que a autora demonstre cabalmente nos autos o fundado temor alegado em sua inicial.

Decisão assinada digitalmente."

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora não comprovou os requisitos.

A parte autora comprou ter diagnóstico de obesidade mórbida, cursando com hipertensão arterial, diabetes mellitus e quadro depressivo, além de dificuldade para deambular (Evento 1, ANEXO11, Páginas 1 e 2).

O NAT juntou parecer no processo 5106203-86.2024.4.02.5101/RJ, evento 16, PARECER1.

O parecer esclareceu que a indicação de cirurgia bariátrica como tratamento de obesidade deverá seguir os critérios dispostos no ANEXO I da Portaria do Ministério da Saúde nº 424, de 19 de março de 20131.

O parecer igualmente esclareceu que a parte autora está inserida, desde 06/06/2024, em consulta em Ambulatório 1ª vez- Cirurgia Bariátrica (Adulto), pela Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba, para o tratamento de obesidade, com situação "Em fila", ocupando a posição de número 2.779 na lista de espera.

Destarte, em havendo outros pacientes em igual ou mais crítica situação clínica do que a da autora, nesta mesma fila de espera e em posição anterior àquela que a mesma ocupa, não se afigura isonômico que, em virtude de ordem judicial, a autora seja submetida de pronto à consulta de que necessita, a despeito dos outros pacientes, que, tanto quanto ela, são titulares do direito constitucional da assistência à saúde, fornecida pelo Estado.

Sobre o tema, o TRF2, já teve oportunidade de se manifestar, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

*CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. **CIRURGIA**. INTO. RESPEITO À **FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA**. 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a **fila** administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes. 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INTO ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a **fila** administrativamente estabelecida. 4. É inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na **fila** de espera. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida.*

(TRF2, Sétima Turma, AP 0113602-43.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, DJe 27/10/2016)

A organização da fila de espera é baseada em critérios médico-científicos, de forma que a intervenção do Poder Judiciário só pode se dar em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante desrespeito à regulação ou de urgência devidamente comprovada, nos termos do Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:

*"ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, **com expressa menção do quadro clínico de risco imediato**."*

A parte autora não comprovou o quadro clínico de risco imediato.

Assim, em uma cognição sumária, pode-se concluir que está ausente a probabilidade do direito pleiteado. Por essas razões, indefiro o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo. Intimem-se."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.